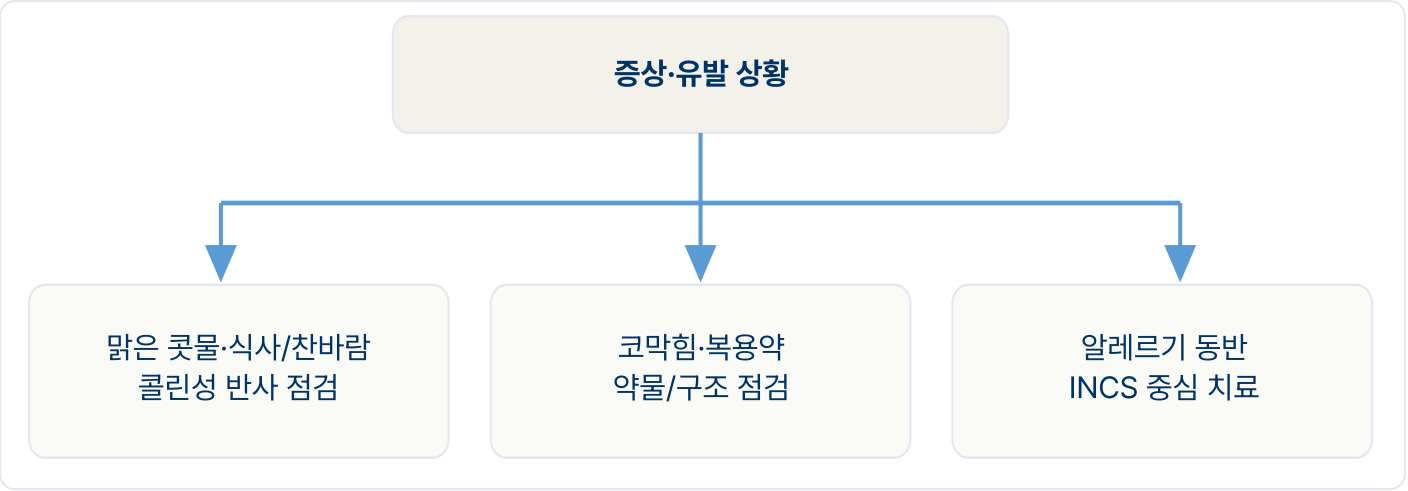
고령·만성질환의 콧물·코막힘

염증·자율신경·구조·복용약을 함께 봅니다



유발 상황을 먼저 질문

찬바람·온도 변화·식사 때 맑은 콧물은 혈관운동성/미각성 비염을 생각합니다. 콜린성 반사에는 항히스타민보다 비강 ipratropium(리노벤트)이 맞습니다. 알레르기와 구조적 폐쇄가 함께 있을 수도 있습니다.

! 약국 스프레이·기존 수술력

비강 충혈완화제의 반복 사용은 약물성 비염을 만듭니다. 중단 뒤 2~3일부터 호전, 대개 1주 내 소실된다고 설명했습니다. 고령·수술/레이저 후 건조·가피는 위축성 원인도 살피고 보습·세정을 고려합니다.

권혁수 연자 Q&A · 고령/심장질환

감기 콧물에는 세척·수분, 필요시 acetaminophen을 기본으로 합니다. 맑은 콧물은 ipratropium 하루 2~3회, 심한 코막힘은 INCS를 짧게, 알레르기 동반 시 2세대 항히스타민을 더합니다. 감기 콧물에 2세대 항히스타민 단독 효과는 거의 없다고 설명했습니다.

복용약을 정리하는 체크 카드

충혈완화제·항히스타민·혈압약을 구분

권혁수 연자 Q&A · pseudoephedrine

조절 안 되는 고혈압·관상동맥질환·부정맥, 갑상선항진증·전립선비대·폐쇄각녹내장·임신 초기에 피합니다. 평균 수축기혈압 약 1 mmHg, 맥박 약 3회/분 상승에도 개인차가 큽니다. 액티피드(triprolidine+슈도에페드린)는 고령·운전·전립선비대에서 권하지 않았습니다.

권혁수 연자 Q&A · 사용 기간

경구제는 반동성 코막힘 대신 불면·떨림·배뇨곤란·혈압/맥박 상승이 문제입니다. 연자 처방 예는 60 mg 하루 2~3회 3~5일, 길어도 1주 이내이며 비염에서는 INCS 효과까지 1~2주 보조입니다. 비강 충혈완화제는 3~5일 이내, 5일 초과를 피합니다.

권혁수 연자 Q&A · 코막힘 유발약

Doxazosin·tamsulosin, amlodipine·nifedipine, hydralazine, 일부 베타차단제·PDE5 억제제를 점검합니다. ARB는 상대적으로 드뭅니다. 주치의와 원인 약 변경을 논의하며 ACE 억제제는 기침 유발약으로 구분합니다.

권혁수 연자 Q&A · 조절 실패

분무법·순응도를 실제로 확인하고 내시경/CT로 폴립·비중격·하비갑개를 평가합니다. 변경이 어려우면 INCS+세척, 비강확장 테이프·머리 높이기·습도를 보완합니다. 고혈압에서는 경구 pseudoephedrine을 피합니다. 하비갑개 비대는 수술 의뢰, 잠을 못 이룰 정도면 수면무호흡 검사를 권했습니다.